

DOI: 10.16305/j.1007-1334.2024.2404027

卢传坚教授从脾肾论治慢性荨麻疹经验撷英

姚丹霓^{1,2}, 郭洁^{1,3}, 罗晓悦³, 王梓霞³, 陈毓麒³, 闫玉红^{1,2}, 卢传坚^{1,2,4,5,6}

1. 广东省中医院(广东 广州 510120); 2. 广东省中医皮肤临床医学研究中心(广东 广州 510120); 3. 广州中医药大学(广东 广州 510006); 4. 省部共建中医湿证国家重点实验室(广东 广州 510120); 5. 粤港澳中医药与免疫疾病研究联合实验室(广东 广州 510120); 6. 广东省中医证候临床研究重点实验室(广东 广州 510120)

【摘要】 介绍卢传坚教授从脾肾论治慢性荨麻疹的临床经验。认为慢性荨麻疹风团之标象,从病理角度看实际属于“水湿”范畴,其发生和反复发作与“水湿运化不利”密不可分,其根本责之于“脾肾阳虚”,慢性荨麻疹的核心病机为“脾肾阳虚为其本,风湿相搏为其标”;强调以“温肾健脾治其本、祛风化湿治其标”为治疗法则,并创制“固本抗敏方”为核心方进行辨证论治,疗效显著。并附验案 1 则。

【关键词】 慢性荨麻疹; 皮肤病; 过敏反应; 中医药疗法; 名医经验

Lu Chuanjian's experience in treating chronic urticaria through spleen and kidney

YAO Danni^{1,2}, GUO Jie^{1,3}, LUO Xiaoyue³, WANG Zixia³, CHEN Yuyi³, YAN Yuhong^{1,2}, LU Chuanjian^{1,2,4,5,6}

1. Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong 510120, China; 2. Guangdong Provincial Clinical Research Center for Dermatology of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong 510120, China; 3. Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong 510006, China; 4. State Key Laboratory for Dampness Syndrome of Chinese Medicine Jointly Established by Province and Ministry, Guangzhou, Guangdong 510120, China; 5. Guangdong-Hong Kong-Macau Joint Laboratory on Chinese Medicine and Immune Disease Research, Guangzhou, Guangdong 510120, China; 6. Guangdong Provincial Key Laboratory for Clinical Research on TCM Syndromes, Guangzhou, Guangdong 510120, China

Abstract: This paper introduces Professor Lu Chuanjian's clinical experience in treating chronic urticaria through the spleen and kidney. Chronic urticaria, characterized by its symptom clusters (a group of pruritic wheals), is pathologically categorized under "water dampness". The onset and recurrence of urticaria are closely linked to the "inefficient transformation of water dampness", fundamentally attributed to "spleen and kidney yang deficiency". The core pathogenesis is identified as "spleen and kidney yang deficiency at its root, with dampness and wind intermingling as its manifestation". The treatment emphasizes "warming the kidney and strengthening the spleen to treat the root, and expelling wind and transforming dampness to target the symptoms". Professor Lu formulates the core formula "Guben Kangmin Fang" (Root-Solidifying and Anti-Allergy Formula) for syndrome differentiation-based treatment. The therapeutic efficacy has proven to be significant. One proven case is provided for illustration.

Keywords: chronic urticaria; skin disease; allergic reactions; traditional Chinese medicine therapy; famous doctor's experience

慢性荨麻疹为临床常见过敏性皮肤病,其发病机

制的中心环节为肥大细胞活化,具体表现为其介导的皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加而致的局限性水肿反应,以瘙痒性风团和(或)血管性水肿为临床特征^[1-2]。现代西医临床中主要应用抗组胺类药物治疗,病情严重时可联合环孢素 A,或适度采用糖皮质激素,或使用生物制剂等药物进行治疗,但上述药物存在一定副作用,不宜长期使用^[3]。慢性荨麻疹可归属于中医学“瘾疹”“瘾痧”“游风”等范畴,《黄帝内经》论曰“少阴有余,病皮痹瘾疹”。中医药治疗本病历史悠久、优势

[基金项目] 国家中医药管理局第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目(国中医药人教函[2022]76号);广东省中医院院内专项(YN2018QL03, YN2022QN13);广东省中医药局广东省名中医传承工作室建设项目(粤中医办函[2023]108号)

[作者简介] 姚丹霓,女,博士,副主任医师,主要从事名医经验传承和中医药防治皮肤疾病的临床研究工作

[通信作者] 卢传坚,教授,博士研究生导师;E-mail: lcj@gzucm.edu.cn

独具,效果显著。

卢传坚教授为“岐黄学者”,第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,国家卫生计生突出贡献中青年专家、广东省名中医及广东省医学(中医药)领军人才。卢教授长期致力于应用中医药治疗难治性免疫性皮肤病的临床和科研工作。慢性荨麻疹是临床常见难治性皮肤病,卢教授在治疗本病方面见解独特,另辟蹊径,善从脾肾论治,常获良效。笔者有幸跟随卢教授门诊,将其对慢性荨麻疹“脾肾阳虚”的核心病机认识进行探析,并将其从脾肾论治慢性荨麻疹的经验总结如下。

1 核心病机阐发

慢性荨麻疹是指病程在6周以上的荨麻疹^[4]。慢性荨麻疹病因复杂,是临床常见、多发、难治性疾病,口服相应西药虽有一定的疗效,但药物具有嗜睡等副作用,影响患者的生活质量。即使是最新的生物制剂,也解决不了本病停药后仍反复发作的难题。针对慢性荨麻疹西药治疗的弊端,以及疾病易复发的难题,中医药治疗具有一定的优势。

中医学认为,瘾疹主因先天禀赋不耐,外加六淫邪气侵袭;或因饮食不节、肠胃湿热;或因平素体弱,气血不足,卫外不固所致^[4]。鉴于本病的基本损害为风团,多与外感、风湿邪气的侵袭有关,因而从风湿论治为常法之一。但对于久治无效、风团反复发作呈慢性病程者,卢教授认为脾肾亏虚是此类慢性荨麻疹反复发作的内在原因。禀赋不耐责之先天之本“肾”;饮食不节,肠胃湿热则影响脾胃;平素体弱,气血不足,卫外不固则与后天之本“脾”的生化不足密不可分。本病的慢性病程,多因脏腑亏虚,病由内生,尤其是与脾肾亏虚有关。

1.1 从皮损的微观角度看病机属“脾肾阳虚” 荨麻疹的主要皮损为风团,中医治疗常从“风邪”的角度对皮损进行辨证;但从病理的角度分析,风团实际上是由于皮肤黏膜小血管扩张,以及血管通透性增加,导致体液外渗到周围组织,聚集在真皮浅层形成的水肿,反映在体表则形成了我们肉眼可见的风团。因此风团的实质责之于中医所言“水湿”,无论瘾疹的发病有多少种起因,但其最终均表现为局部的肿胀、风团的隆起,均为津液代谢的异常导致局部“水湿”聚集。人体水湿的代谢和运化,离不开肺、脾、肾三脏。“诸湿肿满,皆属于脾”,因此局部水湿的聚集,提示土不克水,脾虚不能运化水湿。而肾主一身之阳气,同时又主温化水饮;肾气不足,日久则肾阳亏虚则易出现阳虚水泛。唐代王冰注释《黄帝内经》中的“病皮痹瘾疹”时认为:“肾水逆连于肺母故也,足少阴脉从肾上贯肝膈入肺中,故有余病

皮痹隐疹。”此段说明,子病及母,即“肾水逆连于肺母”,而影响肺输布津液的功能,导致水湿在肌表停滞。虽然很多急性荨麻疹或荨麻疹急性发作患者均是从“肺”论治,但慢性荨麻疹病程日久且易反复,此时固肾可更好地通调水道。肾为一身阴阳之根本,内藏元阴、元阳,它既是“先天之本”,也是“脏腑之本、十二经脉之根、呼吸之本、三焦之源”。有学者^[5]认为,顽固性、难治性慢性荨麻疹与肾虚密切相关。除此之外,现代医学认识到某些特殊类型荨麻疹,如遗传性家族性荨麻疹综合征、局限性热荨麻疹、家族性冷性荨麻疹等,其发生与遗传因素关系密切,这与中医认为其“肾气不足”在某些程度上不谋而合^[6]。

临床上中医辨证荨麻疹,其常见的证候包括卫外不固、营卫不和。而营卫之气来自水谷精微,水谷精微由脾胃生化,若脾胃亏虚,则营卫生化不足。《丹溪心法》曰:“瘾疹多属脾。”脾土位居中央以溉灌四傍,与胃共主气机升降、水谷运化。若脾升清降浊功能失司,则水湿运化不利容易出现“湿浊”聚集于局部,且“湿浊”缠绵反复,同样也责之于脾。因此,卢教授认为,患者出现反复的风团发作,其实跟体内“水湿”运化不利有密切的关系,从根本上讲,常定位在脾肾。

1.2 从临床症状和体质特点看病机属“脾肾阳虚” 卢教授认为,慢性荨麻疹患者多数有一些共同的临床特点,比如常伴有畏冷、畏风,动则自汗出等卫表亏虚的症状,常夜间发作。夜间卫气由表入里,阳气较弱,卫气若不固密,容易受风邪、寒邪侵袭而致风团发于肌肤。冬春季交替或秋冬季交替也是慢性荨麻疹发作的高峰期。脾乃气之源,肾乃气之根,故此类脾肾不足的患者,内里无阳气可固密体表,对于气温的变化比较敏感,容易诱发的除了慢性荨麻疹外,有些患者常同时伴发过敏性鼻炎、哮喘等,或发生与寒冷诱发有关的过敏性疾病。由此可见,营卫不足是荨麻疹风团瘙痒发作的直接原因,而追本溯源,仍责于脾肾不足。《灵枢》云:“营出中焦,卫出下焦。”中焦脾胃不足,下焦肾元亏虚,日久营卫必然受损,乃是本病久治不愈的根源所在。

文献^[7]报道,慢性荨麻疹常伴随幽门螺杆菌感染或桥本甲状腺炎,此类患者常伴有胃肠道症状,如腹胀、纳呆、便溏、流涎等临床症状,这与脾虚的证候表现相吻合。甚至有些患者可出现畏寒等阳虚的证候。从患者的伴随症状来看,临床上大部分患者常伴有“大便溏稀,畏寒,舌淡胖、边有齿印,舌苔白或白腻,脉沉细”等阳虚的表现。国内流行病学调研文献^[8]显示,慢性荨麻疹患者体质中气虚质、阳虚质占大多数,应充分重视阳虚质、气虚质体质在慢性荨麻疹发病中的重要作用。因此,慢性荨麻疹之“阳气虚、卫气不固、营血亏虚”,究其根本还是在于脾肾亏虚,尤其是脾肾阳虚。卫气充

足的根本,一是责之先天之本的肾气,二是责之后天之本的脾胃。因而,脏腑应定位在脾肾,病性常为阳虚,脾肾阳虚较卫气亏虚可更加揭示患者发病的本质。另外,使用固肾健脾的中药复方,可有效调节脾肾阳虚型慢性荨麻疹患者血清免疫球蛋白E(IgE)、白细胞介素-4(IL-4)的水平,以减少复发^[9]。

2 治法方药特色

2.1 治疗首重温肾健脾,其次祛风化湿 卢教授认为,慢性荨麻疹发病以脾肾阳虚为本,以风湿相搏为标。因此,治疗首重扶正、其次祛邪,治疗多以健脾温肾治其本、祛风化湿治其标为法,常获良效。

针对此核心病机和治疗法则,卢教授自拟“固本抗敏方”用于治疗慢性荨麻疹,该方由七味药组成,即干姜、淫羊藿、黄芪、白术、白鲜皮、五味子、防风。方中干姜、淫羊藿共为君药,干姜性热味辛、归脾肾经,温中助阳散寒同时可燥湿、利水消肿,然干姜性温燥,故而又配伍温而不燥的淫羊藿,其性温味辛甘、归肾经,可补肾阳、祛风湿;干姜性热味辛,温阳之力强,得淫羊藿配伍的助力,不仅可使肌表阳气充盛,还可使肌表阳气之生化连绵不绝,解决阳气生化不足的关键问题。黄芪、白术共为臣药,黄芪性微温味甘、归肺脾经,善补气升阳、固表止汗、利水消肿,为益气升阳必用之药,能疏通三焦而导营卫之气上行;白术性平、味辛苦甘,既能补脾,又能升脾阳而化湿浊。白鲜皮与五味子共为佐药,白鲜皮性寒味苦,具有燥湿清热、祛风止痒之功,此处应用一是取其性寒制约君药之热,二是因其具有祛风燥湿止痒的功效可缓解瘙痒症状;五味子性平和,因具甘、酸、辛、苦、咸五味而得名,能滋肾、敛肺、止汗,用其制约君药发散太过,《本经疏证》谓五味子善于“收阳中之阴气”,即善于调整肺中的阴阳失衡,将多余的亢盛阳气下收于肾,以恢复肌表阴阳的平衡。防风性微温味辛甘,能祛风除湿解表,因其善于走表,能引诸药之力行于肌表,使全方温阳托里固表,为使药。

2.2 固本大法中对“温肾”与“健脾”的辨证加减 卢教授认为,脾肾阳虚型慢性荨麻疹患者临床上的皮疹也可表现为红色的风团,水湿代谢异常聚于局部,郁而化火亦可出现该表征,因此不能一看到红斑就辨证为风热,用局部辨证代替整体辨证。对于慢性荨麻疹,舌脉是整体辨证的关键,问诊可以帮助了解患者本虚的严重程度。慢性荨麻疹患者常见皮疹呈慢性、反复发作或夜间发作,除舌淡、脉细或沉的气虚表现之外,患者还常伴有明显的腰酸、关节晨僵、夜尿多、大便偏软而不成形的症状,常辨证为脾肾阳虚证。治疗时,卢教授会根据患者的临床表现对“温肾”和“健脾”各有侧重。若患者伴有关节晨僵、畏寒、腰酸、夜尿多等,卢教授常

以“温肾”为主、“健脾”为辅,此时会加大黄芪的用量至30 g,将上方中的淫羊藿改为巴戟天,或加益智仁等以加强温肾补阳之功,或加狗脊、杜仲以壮腰背阳气;若伴有夜尿清长,加覆盆子、桑螵蛸、金樱子以固精缩尿;若患者以纳呆、便溏、腹胀、暖气等脾虚症状为主,卢教授则以“健脾”为主、“温肾”为辅,常在上述基本方基础上加入大腹皮、枳壳、佛手、厚朴等行气理气之品,使得黄芪补而不滞,旨在补气行气以固本,使得脾胃健运,恢复其正常的升降生理功能。

2.3 祛邪大法中对“祛风”与“化湿”的辨证加减 慢性荨麻疹常分为急性发作期和缓解期,在急性发作期,其标象明显,此时除了固本之外,祛除“风湿”邪气同样重要。通过皮疹的局部辨证,以辨明“风”与“湿”的深浅和轻重。若患者表现以皮肤局部肿胀为主,伴有局部水肿明显,且以舌苔为水滑苔或者舌苔白腻为主,或伴有口苦者,辨证为“湿”重于“风”,此时治疗邪气需加大祛湿的力度,在“固本抗敏方”中防风祛风除湿的基础上,配合健脾利湿之茯苓,芳香化湿之佩兰、厚朴,利水渗湿之泽泻,或局部红斑明显时加土茯苓以清热利湿。若水湿聚于下焦,需注意是否同时合并有中气下陷的表现,若有脾气亏虚,又出现便溏、关节晨僵等,切不可同时合用二妙丸、四妙丸之类的清热利湿药物,而需加大黄芪的用量,同时可合用祛风除湿之品如徐长卿以升阳利湿。

对于发病因外感受凉而起,其发病部位不固定,出现游走性强、瘙痒明显、以夜间发作为主的风团,同时舌苔薄者,可辨证为“风”重于“湿”,常酌加祛风之品如徐长卿,既可祛风活血,又可配伍“固本抗敏方”中的白鲜皮以加强祛风除湿止痒之功,这是卢教授常用的止痒药对;或加白蒺藜、浮萍等,可与防风形成药对以加强祛风的功效。

3 验案举隅

罗某,女,34岁。初诊日期:2022年7月1日。

主诉:反复全身皮肤风团伴瘙痒9个月余。现病史:9个月前患者全身皮肤出现风团伴瘙痒,至当地医院就诊,诊断为荨麻疹,经抗过敏药物治疗后好转,但停药后反复。随后病情反复,患者辗转于多家医院治疗,疗效欠佳。患者曾先后静脉滴注地塞米松磷酸钠、复方甘草酸苷及葡萄糖酸钙注射液,并先后口服多种抗过敏药物及采用自血疗法等进行治疗。治疗时症状可控制,但停药后病情反复。刻下:患者皮肤仍有风团发作,目前维持每2日口服盐酸西替利嗪片10 mg,风团控制欠佳;无口干口苦,伴有动则汗出、手足冷、腰酸、恶风,纳可,睡眠一般、梦多,偶有大便黏滞;舌淡暗、边有齿痕,舌苔薄白,脉沉细。平素月经周期规律,无痛

经,伴血块,经前常乳胀。专科检查:全身散在淡红色风团、部分呈环状,压之褪色,消退后不留痕迹,未见抓痕、血痂。

西医诊断:慢性荨麻疹;中医诊断:瘾疹;中医辨证:脾肾阳虚证;治法:温肾健脾,祛风除湿止痒。处方:干姜 10 g,巴戟天 10 g,黄芪 15 g,炒白术 15 g,白鲜皮 15 g,五味子 10 g,防风 10 g,炙甘草 10 g,煅牡蛎 30 g(先煎),北沙参 20 g。水煎,每日 1 剂,早晚分服。

二诊(7月19日):患者坚持口服中药,西药停药 1 周余,近期无风团发作,无明显瘙痒;轻微口干,无口苦,自汗减轻,手足冷,恶风,纳可,睡眠一般、梦多,大便时干时稀,小便调;舌淡红、边有齿印,舌苔白,脉细。月经周期规律,量适中,无痛经,伴有少量血块,经前轻微乳胀伴腰酸。守法继进,前方改北沙参 30 g,加厚朴 15 g、香薷 15 g。煎服法同前。

4 周后随访患者,患者述中药服完后皮肤已无风团发作,遂未来就诊,嘱患者可继续口服中药以巩固疗效。

按 本例患者病史 9 个月,属于慢性荨麻疹,患者就诊时有红色风团,伴自汗、恶风、手足冷、腰酸,既往月经伴血块,结合舌脉,一派里虚内寒之象,且已累及肾,中医辨证属脾肾阳虚。卢教授认为,结合本例患者自汗恶风的症状,若按通常的治疗思路,可能会使用桂枝汤或玉屏风散,但结合舌脉,深究其卫气亏虚的根源,则责之脾肾阳虚。一方面脾肾阳虚,火衰生化不足导致气血亏虚,血虚日久化燥生风导致瘙痒,卫阳不足导致卫气温煦腠理的功能失司,因此容易感受外来风邪,导致风邪搏结于腠理而发为红色风团;虚寒血凝,阳虚还导致患者月经伴血块,脾虚则升清降浊功能失司,出现大便黏滞。尽管局部辨证存在风湿热之邪,但其整体辨证以阳虚为主,因此,治疗当以固本为主,祛邪为辅。

根据慢性荨麻疹的核心病机“脾肾阳虚为本,风湿相搏为标”,卢教授以“温肾健脾,祛风除湿止痒”为法,以自拟“固本抗敏方”为基础进行加减,患者阳虚症状较明显,卢教授改原方淫羊藿为巴戟天,配伍干姜为君药以温脾补肾。巴戟天性温、味辛甘,归肾经,此处取其补肾阳、祛风湿之功,通过温下焦阳气以助脾阳。在“固本抗敏方”的基础上加炙甘草配合干姜,以使得药力和缓,取“少火生气”之意。加北沙参以益气养阴以防温补太过,且北沙参与五味子配伍可敛阴益气而巩固卫表。患者局部皮损呈红色风团并伴有多梦,考虑为风湿缠绵不去,郁而化热,热扰心神,原方中有白鲜皮可以清热燥湿、祛风止痒,能缓解慢性荨麻疹瘙痒明

显的症状,并加煅牡蛎,以其性微寒味咸发挥重镇安神、潜阳补阴的功效,能入肾而使阳气安潜。

二诊时,患者服中药近 3 周后,尽管手足冷、恶风等症状仍未完全消失,但患者已能停药西药 1 周,且服中药期间风团未发作,舌质由淡暗转为淡红,说明患者的阳气较前逐渐恢复,大便性状也较前有所改善。二诊时患者的舌苔由薄白转为白苔,湿邪聚集明显,说明脾虚仅靠温补还不够,脾胃为中枢,需健运才能更好地运化水湿,当加燥湿祛湿药物,辅助脾胃恢复升清降浊功能。因此在前方基础上加厚朴以行气燥湿,加香薷以行水散湿、温胃调中,同时为防利湿伤阴,加大北沙参剂量。4 周后电话随访,患者已停药中药且已无风团发作。卢教授认为,一般治疗此类患者,疗程最好为 8 周至 12 周以进一步温肾健脾,后期可加强固本,以减少复发的可能。

4 结语

慢性荨麻疹为临床常见的慢性难治性皮肤病,其病情常缠绵反复、迁延难愈,严重影响患者的生活质量。卢教授基于多年临床经验,认为慢性荨麻疹的病机核心在于脾肾阳虚,主张立足脾肾二脏论治,据此提出“温肾健脾治其本,祛风化湿治其标”的治则并创制经验方“固本抗敏方”。运用此核心方时,卢教授亦根据患者的症状对“健脾”和“温肾”、“祛风”和“除湿”各有一定的侧重以辨证加减,临床疗效显著。

参考文献:

- [1] 窦智,张懿. 中医药治疗慢性荨麻疹研究进展[J]. 山西中医, 2019, 35(11): 57-58, 62.
- [2] 费晓军,章旭,杜欢. 黄煌运用“方-病-人”临证思维模式治疗慢性荨麻疹经验[J]. 上海中医药杂志, 2021, 55(7): 42-44.
- [3] 中华医学会皮肤性病学分会. 中国荨麻疹诊疗指南(2022版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2022, 55(12): 1041-1049.
- [4] 中华中医药学会皮肤科分会. 瘾疹(荨麻疹)中医治疗专家共识[J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2017, 16(3): 274-275.
- [5] 王明香,马望琪. 温补肾阳法治疗慢性顽固性荨麻疹 30 例[J]. 陕西中医, 2013, 34(6): 723-724.
- [6] 展照双,王加锋. 从“冬不藏精,春必病温”探讨荨麻疹发病机制[J]. 山东中医杂志, 2014, 33(11): 879, 899.
- [7] 宋鑫鑫. 影响慢性荨麻疹疗效的相关因素研究[D]. 济南:山东大学, 2013.
- [8] 周俊琳,黎舒敏,邱鸿琳. 150 例慢性荨麻疹患者中医体质分布及发病相关影响因素分析[J]. 广西中医药大学学报, 2020, 23(1): 23-25.
- [9] 石志峰,殷致宇. 附子理中汤加减对脾肾阳虚型慢性荨麻疹患者 IgE、IL-4 水平的影响[J]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2020, 4(1): 117-118.

编辑:黄博韬

收稿日期:2024-04-07